

Protocolo de Identificação e Manejo Inicial da Sepse

Hospital Cooperativo Serra Azul — Serra Azul (SC)

Identificador	PROT-001
Instituição	Hospital Cooperativo Serra Azul
Especialidade	medicina_intensiva
Versão	2
Vigência	2025-04-01
Próxima revisão	2027-04-01
Responsável técnico	Comissão de Protocolos Assistenciais
Situação	VIGENTE

1. Objetivo

Padronizar a identificação precoce e o manejo inicial de pacientes adultos com suspeita de sepse nas unidades de internação e no pronto atendimento do Hospital Cooperativo Serra Azul, reduzindo o tempo entre a suspeita e o início das medidas iniciais.

2. Abrangência

Aplica-se a pacientes adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, atendidos no pronto atendimento, nas unidades de internação e na unidade de terapia intensiva. Não se aplica a pacientes pediátricos nem a gestantes, que possuem protocolos próprios não abrangidos por este documento.

3. Definições

Sepse: disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por resposta desregulada do organismo a uma infecção presumida ou confirmada.

Choque séptico: subconjunto da sepse no qual as alterações circulatórias e metabólicas são profundas o suficiente para aumentar substancialmente a mortalidade.

Tempo zero: momento do primeiro registro em prontuário de sinais compatíveis com suspeita de sepse. Todos os prazos deste protocolo são contados a partir do tempo zero.

4. Critérios de triagem

A triagem deve ser aplicada por qualquer profissional da equipe assistencial diante de foco infeccioso presumido associado a pelo menos dois dos sinais abaixo:

- Frequência respiratória igual ou superior a 22 incursões por minuto.
- Alteração aguda do nível de consciência em relação ao basal.
- Pressão arterial sistólica igual ou inferior a 100 mmHg.
- Temperatura axilar inferior a 36 °C ou superior a 38 °C.

A triagem positiva obriga a comunicação imediata ao médico assistente e a abertura da ficha de acompanhamento do protocolo.

5. Pacote de primeira hora

As medidas abaixo devem ser iniciadas dentro de sessenta minutos contados a partir do tempo zero.

Medida	Prazo	Responsável
Coleta de lactato sérico	até 30 min	Enfermagem
Coleta de hemoculturas antes do antimicrobiano	até 45 min	Enfermagem
Início de antimicrobiano de amplo espectro	até 60 min	Médico assistente
Reposição volêmica conforme avaliação clínica	até 60 min	Médico assistente
Reavaliação de lactato se o inicial estiver alterado	entre 2 h e 4 h	Médico assistente

A escolha do antimicrobiano segue o mapa microbiológico vigente da instituição, atualizado semestralmente pela Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Este protocolo não define esquema antimicrobiano específico.

6. Critérios de acionamento da equipe de terapia intensiva

Aciona-se avaliação da equipe de terapia intensiva quando presente qualquer um dos critérios:

- Hipotensão persistente após reposição volêmica inicial.
- Lactato sérico acima de 4 mmol/L.
- Necessidade de suporte ventilatório.
- Redução do débito urinário mantida por mais de duas horas.

O acionamento da equipe de terapia intensiva descrito nesta seção é distinto do acionamento do Time de Resposta Rápida, cujos critérios estão definidos em procedimento operacional próprio.

7. Indicadores de monitoramento

- Proporção de pacientes com lactato coletado dentro de 30 minutos.
- Proporção de pacientes com antimicrobiano iniciado dentro de 60 minutos.
- Tempo mediano entre o tempo zero e a primeira medida do pacote.

Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração
1	2023-05-02	Versão inicial.
2	2025-03-10	Inclusão do pacote de primeira hora e revisão dos critérios de triagem.

DOCUMENTO FICTÍCIO — gerado por software para demonstração técnica do projeto SCMedAI. Não é um protocolo clínico real, não foi validado por nenhuma instituição de saúde e **NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ORIENTAR CUIDADO A PACIENTES.**